



UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA – UNOESC
CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
CURSO DE CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
PRÁTICA EXTENSIONISTA II

Práticas Extensionistas III:

Desenvolvimento de sistema de gestão de consultas

Desenvolvedores:
Guilherme Victor Colossi, Cauã Sehn Essing

Xanxerê - SC, 26 de Abril de 2026

1. CONTEXTUALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA

O acesso à saúde pública no Brasil enfrenta desafios significativos relacionados à alta demanda, à falta de organização e à sobrecarga dos postos de atendimento à saúde. Atualmente, o processo de agendamento de consultas e retirada de medicamentos ainda é em grande parte manual e presencial. Essa realidade faz com que os pacientes precisem comparecer aos postos de saúde com antecedência, enfrentando longas filas e esperas mesmo quando já possuem horário marcado.

A superlotação nos postos é agravada pela necessidade de atendimento prioritário a idosos, gestantes e crianças, um direito garantido por lei, mas que na prática torna o processo de organização ainda mais complexo devido à ausência de um sistema estruturado. O resultado é um ambiente desgastante tanto para os pacientes quanto para os profissionais de saúde, que precisam lidar com imprevistos, encaixes de última hora e a falta de controle eficiente dos horários disponíveis.

Entre os grupos mais prejudicados por essa dinâmica estão os trabalhadores com jornadas de trabalho fixas, mães com crianças pequenas e gestantes que precisam realizar acompanhamentos mensais. Essas pessoas muitas vezes não dispõem de tempo para permanecer horas em filas e necessitam de atendimentos considerados simples e rápidos. A falta de organização e de um sistema digital eficiente resulta na perda de consultas, no acúmulo de atendimentos e em longos períodos desnecessários passados nos postos de saúde.

Diante desse contexto, o projeto propõe o desenvolvimento de um site voltado à organização de agendamentos e requisições de medicamentos em postos de saúde, com o objetivo de otimizar o atendimento e reduzir a superlotação. O sistema permitirá que pacientes realizem o agendamento de consultas de forma digital, visualizem horários disponíveis, recebam a confirmação dos responsáveis do posto e tenham acesso ao histórico de atendimentos e prescrições. Além disso, será possível solicitar medicamentos e marcar horários específicos para a retirada, contribuindo para um fluxo mais organizado e previsível.

Embora se reconheça que parte da população atual, especialmente os idosos entre 60 e 80 anos ainda apresente dificuldades no uso de tecnologias digitais, a proposta prevê uma implantação gradual, com foco inicial em públicos que já possuem maior familiaridade com ferramentas online, como adultos entre 20 à 40 anos e acompanhantes de pacientes com mais de 65 anos. Essa fase inicial visa construir a base de funcionamento e aceitação do sistema, preparando o caminho para um uso mais amplo nas próximas décadas.

Em uma perspectiva futura, à medida que as gerações mais jovens envelheçam, o uso de tecnologias digitais na saúde pública tende a se tornar natural. Assim, o projeto não apenas busca resolver problemas imediatos de organização e eficiência, mas também preparar o sistema público de saúde para uma transição digital inevitável, capaz de beneficiar as comunidades a médio e longo prazo.

2. STAKEHOLDERS DO PROJETO

Os stakeholders do projeto correspondem às partes interessadas que são direta ou indiretamente impactadas pela solução proposta. A identificação desses atores foi essencial para garantir que o sistema atendesse às reais necessidades da comunidade.

Foram identificados como principais stakeholders:

- **Pacientes do sistema público de saúde**, que utilizam os serviços das unidades básicas e são diretamente beneficiados pela facilidade de agendamento, redução de filas e acesso ao histórico de atendimentos.
- **Profissionais administrativos das unidades de saúde**, responsáveis pela organização das agendas, atendimento ao público e controle de consultas e medicamentos.
- **Profissionais da área da saúde**, como médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, que dependem de uma agenda organizada para otimizar o atendimento aos pacientes.
- **Gestores públicos da área da saúde**, responsáveis pelo planejamento, tomada de decisão e alocação de recursos.

Durante o desenvolvimento do projeto, as necessidades desses stakeholders foram consideradas de forma central, servindo como base para a definição das funcionalidades do sistema. As entrevistas e relatos coletados permitiram compreender as expectativas, limitações e prioridades de cada grupo, garantindo que o protótipo desenvolvido representasse uma solução alinhada à realidade da comunidade.

A participação indireta da comunidade ocorreu por meio dos relatos dos usuários e profissionais, fortalecendo o caráter extensionista do projeto e assegurando que a proposta estivesse voltada ao interesse público.

3. ANÁLISE DE REQUISITOS

Durante a análise de requisitos, foram identificados os seguintes requisitos funcionais:

RF01– O sistema deve proporcionar uma tela à pacientes para agendamento de consultas de forma online, disponibilizando a escolha da especialidade necessária e horários disponíveis.

RF02– O sistema deve permitir que os pacientes consultem horários disponíveis e especialidades médicas.

RF03– O sistema deve enviar lembretes automáticos aos pacientes sobre as consultas agendadas.

RF04– O sistema deve permitir que os pacientes cancelem ou remarquem suas consultas, liberando automaticamente a vaga para outros usuários.

RF05– O sistema deve permitir que os pacientes solicitem a retirada de medicamentos.

RF06– O sistema deve oferecer aos gestores um painel de controle centralizado das agendas médicas.

RF07– O sistema deve gerar relatórios e estatísticas sobre atendimentos realizados, cancelamentos e demandas de consultas.

RF08– O sistema deve permitir que o paciente visualize o histórico de consultas realizadas, canceladas e futuras.

RF09– O sistema deve exibir o endereço completo e o mapa do local da consulta, além de proporcionar opções de transportes que ajudem o paciente a chegar nesse destino

RF10– O sistema deve permitir acesso, mesmo com conexão instável ou lenta, mas de forma limitada (para visualização de consultas e histórico)

RF11– O sistema deve permitir que o paciente escolha o meio preferido para receber notificações (WhatsApp, SMS, e-mail ou aplicativo).

RF12– O sistema deve solicitar confirmação do comparecimento do paciente com até 24 horas de antecedência.

RF13– O sistema deve permitir que o paciente visualize prescrições ou orientações fornecidas após a consulta.

Além disso, foram discernidos alguns requisitos não funcionais:

RNF01– O sistema deve possuir uma interface simples, intuitiva e acessível, especialmente para usuários idosos.

RNF02– As mensagens exibidas devem usar linguagem simples, respeitosa e de fácil compreensão para todos os públicos.

RNF03– O sistema deve ser responsivo, permitindo o uso adequado tanto em dispositivos móveis quanto em computadores.

RNF04– O tempo de resposta do sistema deve ser inferior a 3 segundos por requisição.

RNF05– O sistema deve garantir o armazenamento seguro e confidencial dos dados de usuários, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).

RNF06– O sistema deve estar disponível 24 horas por dia, com necessidade mínima de manutenção.

RNF07– O sistema deve ser otimizado, de forma que certas funções essenciais funcionem adequadamente mesmo em redes móveis com baixa velocidade (3G ou inferior).

RNF08– O sistema deve realizar backups automáticos diários para evitar perda de informações.